

БЕКТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин ал-
дындагы Дары каражаттары жана меди-
циналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары

Кысанов Т.М.

« 4 »

2025-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ПИЛОРЕКС

Соодадагы аталышы

Пилорекс

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Кларитромицин + Омепразол + Тинидазол

Дарынын түрү

Пероралдуу колдонуу үчүн бириктирилген топтом.

Курамы

Ар бир блистер төмөнкүлөрдү камтыйт:

А. 250 мг дан Кларитромицин USP эки таблеткасы

Жука чел кабык капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Кларитромицин USP 250 мг

Көмөкчү заттар: микрокристаллдуу целлюлоза (РН 112), натрий кроскармеллозасы, тазартылган тальк, магний стеараты, стеропакс, жүгөрү крахмалы, коллоиддүү суусуз кремний диоксиди, натрий крахмалгликоляты.

Жука чел кабыгы: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тазартылган тальк, макроголдор (полиэтиленгликоль-6000), титан диоксиди.

В. 20 мг дан USP узакка бошонуп чыгуучу омепразолдун эки капсуласы.

Ар бир капсула төмөнкүлөрдү камтыйт:

Омепразол USP 20 мг

(ичегиде эрүүчү пеллет түрүндө).

С. 500 мг дан Тинидазолдун эки таблеткасы.

Жука чел кабык капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Тинидазол ВР 500 мг

Көмөкчү заттар: коллоиддүү суусуз кремний диоксиди, повидон (PVPK-30), жүгөрү крахмалы, микрокристаллдуу целлюлоза, метилгидроксibenзоат, пропилгидроксibenзоат, тазартылган тальк, магний стеараты, натрий крахмалгликоляты (А тиби).

Жука чел кабыгы: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), тазартылган тальк, макроголдор (полиэтиленгликоль-6000), титан диоксиди, хиолин сары боёгучу.

Препараттын сүрөттөмөсү:

1. Кларитромицин - Жука чел кабык капталган, сүйрү, эки жагы томпок ак таблеткалар.
2. Омепразол – Карамель-кызгылт түстөгү, “2” өлчөмдө, актан дээрлик ак түскө чейинки мүнөздүү пеллеттерди камтыган катуу желатиндүү капсулалар.
3. Тинидазол - Жука чел кабык капталган, сары түстөгү, сүйрү, эки жагы томпок таблеткалар.

Фармадарылык тобу: Жарага каршы препараттар жана гастроэзофагеалдык рефлюксту дарылоо үчүн препараттар. *Helicobacter pylori* эрадикациясы үчүн бириктирилген препараттар.

АТХ коду: A02BD.

Фармакологиялык касиети

Фармакодинамикасы:

Кларитромицин көпчүлүк грамон, грамтерс аэробдук жана анаэробдук микроорганизмдер, анын ичинде *H. pylori* ге каршы бактерияга каршы активдүүлүккө ээ, макролиддик антибиотик болуп эсептелет. Кларитромицин сезгич микроорганизмдердин рибосомаларынын 50s суббирдиги менен байланышат, бул синтези бактериялык РНКга көз каранды белок синтезин басууга алып келет. Кларитромицин *H. Pylori*/ге каршы *in vitro* да, ошондой эле *in vivo* да активдүүлүккө ээ.

Омепразол H^+ - K^+ - АТФ-аза ферментин басандатуу аркылуу ашказандагы туз кислотасынын секрециясын төмөндөтөт, бул туз кислотасынын акыркы баскычын бөгөйт. Анын натыйжасында дүүлүктүргүчтүн табиятына көз карандысыз базалдык жана түрткү берилген секреция төмөндөйт. Омепразол микробго каршы таасир үчүн жакшыраак чөйрөнү камсыз кылат. Ал *H. pylori* нин өсүшүн басат. Кларитромицин жана омепразолду бир убакта куюу эки препараттын тең фармакокинетикасына оң таасир берет.

H. pylori эрадикациясынын жыштыгы бул айкалышка анаэробдук бактерияларга жана жөнөкөйлөргө каршы, ошондой эле *H. pylori* каршы микробго каршы активдүүлүгү бар нитроимидазолдор тобунун өкүлү болуп эсептелген тинидазолду кошууда билинерлик көбөйөт.

Тинидазол ДНК синтезин басат жана ДНК спиралдык түзүлүшүн жоготууга алып келет.

Ошентип, омепразол антибиотик менен дарылоо айкалышында симптомдорунун тез жеңилдешин жана жаранын айыгышын камсыз кылат.

Фармакокинетикасы:

Бириктирилген топтомго кирген үч препарат тең ичкенден кийин жакшы сиңет.

Омепразол абсолюттук биожеткиликтүүлүгүндө 40% тегерегинде тез сиңет. Омепразолдун сиңишине тамак таасир бербейт. Ал боордо экстенсивдүү зат алмашууга дуушар болот. Кан плазмасынан препаратты жарым-жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 0,5-1 сааттын тегерегин түзөт. Болжол менен 80% омепразол бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгат. Пероралдуу колдонуудан кийин омепразолдун антисекретордук таасиринин башталышы 1 сааттан кийин белгиленет. Ашказанда туз кислотасынын секрециясынын басылышы 24 сааттын тегерегин түзөт. Препаратты күнүгө 20мг дозада кайталап куйгандан кийин ашказан ичиндеги суткалык кычкылдыгы 97% төмөндөйт.

Кларитромицин организмдин ткандарында, анын ичинде ашказандын былжырлуу чел кабыгында жана он эки эли ичегиде кеңири тарайт. 250 мг кларитромицинди куйгандан кийин кан сары суусундагы эң жогорку концентрациясы кларитромицин жана анын активдүү метаболити - 14-гидроксикларитромицин үчүн ылайыгына жараша 0,6 жана 0,7 мкг/мл түзөт. Плазмадан препаратты жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 3-4 сааттын тегерегин түзөт. Кларитромициндин болжол менен 20% бөйрөк аркылуу өзгөрүлбөгөн препарат түрүндө, ал эми 15% 14-гидроксикларитромицин түрүндө бөлүнүп чыгат. Омепразол жана кларитромицинди бир убакта куюу кларитромициндин фармакокинетикалык касиетин жагымдуу өзгөртөрү көрсөтүлгөн. Ашказан ткандарындагы жана былжырдагы кларитромициндин концентрациялары ошондой эле аны омепразол менен бир убакта куюуда жогорулаган.

Тинидазолдун биожеткиликтүүлүгү 100% тегерегин түзөт. Кан плазмасынан препаратты жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили болжол менен 12-14 саатты түзөт. Препарат организмдин ткандарына тез тарайт.

Тинидазол өт аркылуу анын кан сары суусундагы концентрациясынын дээрлик 50% түзгөн концентрацияда бөлүнүп чыгат. Кабыл алынган дозанын болжол менен 25% өзгөрүлбөгөн түрдө заара аркылуу бөлүнүп чыгат. Метаболиттер заара аркылуу бөлүнүп чыгат жана дагы болжол менен 12% түзөт. Тинидазолдун бир аз өлчөмү заң аркылуу чыгат.

Колдонууга көрсөтмө

- ашказан жана он эки эли ичегинин жара оорусу жана *Helicobacter pylori* эрадикациялары;
- *Helicobacter pylori* ассоциацияланган өнөкөт гастрит.

Каршы көрсөтмө

Кларитромицин:

- өтө сезгичтик (анын ичинде эритромицинге жана башка макролиддерге);
- порфирия;
- цизаприд, пимозид, астемизол, терфенадинди бир убакта ичүү.

Омепразол:

- омепразолго жогору сезгичтик;
- нелфинавир менен бирге колдонуу;

- 2 жаштан төмөн жана дене салмагы <20 кг балдар (рефлюкс-эзофагитти дарылоодо, зарнаны белгилерине жараша дарылоо жана гастроэзофагеалдык рефлюкс оорусунда кычкыл кекирүү);
- 4 жаштан төмөн балдар (*Helicobacter pylori* пайда кылган он эки эли ичеги жара оорусунда).

Тинидазол:

- тинидазолго жогорку сезгичтик;
- кан жаратуунун бузулушу;
- 12 жашка чейинки балдар курагы.
-

Кош бойлуулук жана бала эмизүү

Пилорекс кош бойлуулукта колдонууга каршы көрсөтүлгөн. Препаратты бала эмизүү мезгилинде колдонуу зарылдыгында бала эмизүүнү токтотуу тууралуу маселени чечүү керек.

Колдонуу жолу жана дозалары

Эки капсула омепразол, эки таблетка кларитромицин жана эки таблетка тинидазолду камтыган бир блистер 1 күн дарылоого дайындалган, мында бир капсула омепразол жана бир таблеткадан кларитромицин жана тинидазол эртең менен кабыл алынат, ал эми калган омепразолдун капсуласы жана калган кларитромицин жана тинидазолдун эки таблеткасы кечинде кабыл алынат. Дарылоонун узактыгы — 10 күн.

Кыйыр таасирлери

Кларитромицин:

Нерв системасы жана сезүү органдары тарабынан: баш оору, баш айлануу, тынчсыздануу, коркуу, уйку качуу, түнкү жаман түш көрүүлөр, кулактын чуулдашу, даам сезүүнүн өзгөрүшү; сейрек — багыттын бузулушу, галлюцинациялар, психоз, деперсонализация, аң-сезимдин чаташуусу, айрым учурларда — ДК токтоткондон кийин өтүп кетүүчү укпай калуу; сейрек парестезия учурлары тууралуу билдирүүлөр бар.

АИЖ органдары тарабынан: АИЖ функциясынын бузулушу (окшуу, кусуу, гастралгия/ичтеги ыңгайсыздык, ич өтүү), стоматит, глоссит, боор трансаминаз активдүүлүгүнүн транзитордук жогорулашы, холестатикалык сарык; сейрек — псевдомембраноздук энтероколит; сейрек гепатиттин өрчүгөн учурлары тууралуу билдирүүлөр бар; ал эми айрым учурларда боор алсыздыгы байкалган.

Жүрөк-кан тамыр системасы жана кан тарабынан (кан жаратуу, гемостаз): сейрек - тромбоцитопения (адаттан башкача кан агуу, кан куюлуу), лейкопения; абдан сейрек - QT аралыгынын узарышы, карынча аритмиясы, анын ичинде карынча пароксизмалдык тахикардиясы, карынчалардын диртилдеши/бүлбүлдөшү.

Заара жыныс системасы тарабынан: кан сары суусундагы креатинин концентрациясынын көбөйүшү, чарымдуу нефриттин өрчүшү, бөйрөк алсыздыгы сейрек учурлары тууралуу билдирүүлөр бар.

Аллергиялык реакциялар: тери бөртмөсү, кычышуу, залалдуу экссудативдик эритема (Стивенс –Джонсон синдрому), анафилактоиддик реакциялар.

Башкалар: микроорганизмдердин туруктуулугунун өрчүшү; сейрек учурларда - гипогликемия (ичүүчү гипогликемиялык каражаттар жана инсулин менен дарылоо маалында).

Омепразол:

Кан жана лимфатикалык система тарабынан: сейрек - лейкопения, тромбоцитопения; абдан сейрек - агранулоцитоз, панцитопения.

Иммундук система тарабынан: сейрек — өтө сезгичтик реакциялары (мисалы, калтыратма, ангионевротикалык шишимик, анафилактикалык реакция/анафилактикалык шок).

Зат алмашуу жана тамактануу тарабынан: сейрек - гипонатриемия; жыштыгы белгисиз - гипомагниемия (оор гипомагниемия гипокальциемияга алып келиши мүмкүн); гипомагниемия ошондой эле гипокалиемия менен байланышта болушу мүмкүн.

Психика тарабынан: көп эмес - уйкусуздук; сейрек - дүүлүгүү, аң-сезимдин чаташуусу, чүнчүү; абдан сейрек - агрессия, галлюцинациялар.

Нерв системасы тарабынан: тез-тез — баш ооруу; көп эмес — баш айлануу, сезимдин бузулушу, уйкусуроо; сейрек - даам сезүүнүн бузулушу.

Көрүү органы тарабынан: сейрек - көрүү дааналыгынын бузулушу. Айрым учурларда омепразолду кан тамыр ичине инъекциялап, өзгөчө жогорку дозаларда алган оор абалдагы бейтаптарда көрүүнүн калыбына келбеген бузулуулары тууралуу маалымдалган, бирок себеп-натыйжа байланышынын болушу аныкталган эмес.

Угуу органы жана лабиринттик бузулуулар тарабынан: көп эмес — баш айлануу.

Дем алуу системасы, көкүрөк клеткасынын органдары жана орто көңдөй тарабынан: сейрек - колко карышуусу.

АИЖ тарабынан: тез-тез — ич өтүү, ич катуу, окшуу, кусуу, ич көбүү, ичтин оорушу; сейрек — ооздун кургашы, стоматит, АИЖ кандидозу, микроскопиялык колит.

Боор жана өт бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: көп эмес - боор ферменттеринин активдүүлүгүнүн жогорулашы; сейрек - гепатит (сарыгы бар же жок); абдан сейрек — боор алсыздыгы, боор алсыздыгы бар бейтаптардагы энцефалопатия.

Тери жана тери алдындагы ткандар тарабынан: көп эмес - дерматит, кычышуу, бөртмө, бөрү жатыш; сейрек — жаргак баш, фотосенсибилизация; абдан сейрек — көп түрдүү эритема, Стивенс — Джонсон синдрому, уулуу эпидермалдык некролиз; жыштыгы белгисиз — курчуу алдындагы канчоонун тери формасы.

Скелет-булчуң жана байланыштыргыч ткандар тарабынан: көп эмес — сан, кырк муун жана омуртка сөөктөрүнүн сыныктары; сейрек - артралгия, миалгия; абдан сейрек — булчуң алсыздыгы.

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: сейрек - чарымдуу нефрит.

Жыныс органдары жана сүт бездери тарабынан: абдан сейрек - гинекомастия.

Жалпы бузулуулар жана бузулуулар: көп эмес - талмоорсуу, четки шишимиктер; сейрек — абдан терчилдик.

Протондук насостун басандаткычтары менен узакка дарылоо мезгилинде карынча glandулярдык кисталарынын пайда болгон учурлары маалымдалган (туз кислотасынын секрециясын басандатуунун натыйжасы болуп эсептелет жана залалсыз калыбына келме мүнөздү алып жүрөт).

Тинидазол:

Тамак сиңируу системасы тарабынан: табиттин төмөндөшү, ооз көңдөйүнүн былжырлуу чел кабыгынын кургашы, ооздун металл даамданышы, окшуу, кусуу, ич өтүү.

Нерв системасы тарабынан: баш оору, баш айлануу, чарчоо, кыймыл координациясынын бузулушу (анын ичинде локомотордук атаксия), дизартрия, четки невропатия, сейрек - карышуулар, алсыздык.

Аллергиялык реакциялар: бөрү жатыш, тери кычышуусу, тери бөртмөсү, ангионевротикалык шишимик.

Башкалар: транзитордук лейкопения.

Ашыкча доза

Симптомдору: кыйыр таасирлери күчөшү мүмкүн.

Дарылоо: белгилерине жараша дарылоо жүргүзүлөт.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Кларитромицин жана теofilлинди бир убакта колдонуу теofilлиндин плазмалык концентрациясын жогорулатууга алып келиши мүмкүн. Кларитромицин жана терфенадинди бир убакта колдонуу терфенадиндин плазмалык концентрацияларын жогорулатат, бул QT аралыгынын узарышына алып келиши жана жүрөк ырпагынын бузулушун пайда кылышы мүмкүн. Кларитромицин жана варфарин сыяктуу ичүүчү антикоагулянттарды бир убакта колдонуу антикоагулянттардын таасирин күчөтүшү мүмкүн. Кларитромицин жана карбамазепин, циклоспорин, фенитоин, дизопирамид, ловаcтатин, вальпроат, цизаприд, пимозид, астемизол, дигоксинди бир убакта колдонуу акыркы каражаттардын концентрацияларын жогорулатууга алып келиши мүмкүн.

Туз кислотасынын секрециясын айкын басуунун натыйжасында омепразол кетоконазол, ампициллин жана темир туздарынын сиңишин өзгөртүшү мүмкүн. Омепразол фенитоин, диазепам, варфариндин элиминацияларын жайлатат.

Тинидазол кыйыр антикоагулянттардын (кан агуунун өрчүү коркунучун азайтуу үчүн дозасы 50% азайтылат) жана этанолдун таасирин күчөтөт (дисульфирам сымал реакциялар). Сульфаниламиддер жана антибиотиктер менен (аминогликозиддер, эритромицин, рифампицин, цефалоспориндер) айкалышат.

Этионамид менен дайындоо сунушталбайт. Фенобарбитал зат алмашууну тездетет.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Пилорекс кабыл алган бейтаптар, алкогольдук ичимдиктерди кабыл албашы керек, себеби тинидазол дисульфирамга окшош алкоголь менен өз ара таасирленет. Препаратты бөйрөк жана боор алсыздыгында этияттык менен колдонуу керек. Бактерияга каршы препараттарды колдонуудан кийин ич өткөккө даттанган бейтаптардагы псевдомембраноздук колит диагнозун кайрадан кароо маанилүү. Органикалык неврологиялык бузулуулары бар бейтаптар препаратты кабыл албашы керек. Пилорекс препараты менен дарылап баштаганга чейин ашказанда залалдуу процесстин болушу мүмкүндүгү жокко чыгарылышы керек, себеби омепразол симптомдорду жашырышы жана

туура диагноз коюуну кыйындатышы мүмкүн.

Боор аркылуу зат алмашуучу дары каражатын ичүү маалында этияттык менен дайындалат. Варфарин же башка кыйыр антикоагулянттар менен бирге дайындоо учурларында протромбиндик убакытты көзөмөлдөө зарыл.

Таржымалында жүрөк ооруларында терфенадин, цизаприд, астемизол менен бир убакта ичүү сунушталбайт.

Чыгаруу формасы

Ар бир алу-ПВДХ блистерде 2 капсула Омепразол, 2 таблетка Кларитромицин жана 2 таблетка Тинидазол.

7 күн дарылоо үчүн эсептелген 7 блистер колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон тангакта.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Сактоо мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси

Vegapharm LLP

Suite 1, 5 Percy Street,

London, W1T 1DG, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

UNIMAX LABORATORIES

Plot No.07, Sector 24, Faridabad,

Haryana, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүмдүн (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареге:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шоорук көч., 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com